「IPS 就労支援プログラム導入ガイド」より抜粋

IPS （Individual Placement and Support：個別就労支援とサポート）基本ルール

1.精神疾患の重症度を対象基準としない

▲「働きたい」と希望すれば精神疾患の種類やその重症度に関わらず，誰にでも支援を提供 する。

▲触法者やアルコール・薬物依存者も対象とする。

2.就労を希望したら，訓練を経ず迅速に就労支援を開始する

▲ なるべく早く一般就労できるよう計画立案をする。

▲ なるべく早く，本人の，職歴，技能，症状，ストレングス，希望などを含んだキャリアキャリアプロファイルを作成し，必要時に更新する。

▲求職情報の収集，職場訪問などの，就労に関するアクションを素早く起こす。

3.本人が望む仕事（一般就労）に就くことを目指す

▲職種や勤務時間等にとらわれない。

▲本人のストレングス，興味，技術や価値観を重視する。

▲仕事に本人を合わせるのではなく，本人に合った仕事を探してくる。

4. 就労スペシャリストは職探しから就労後の支援を,期限を定めずに行う

▲支援の期限は本人が決定する。

▲目標は『自立』であるので，支援量を徐々に減らしていける介入を心がける。

5.就労スペシャリストは雇用主の開拓，雇用後の雇用主へのアドバイスを行う

▲目標として，最低週 6 人の雇用主に会って情報情報収集する。

▲雇用主と信頼関係を構築することを重要視する。例えば，離職者が出ても，次の求職者を紹介できる信頼関係を作ることを目標とする。

6. IPS による就労支援は医療チームと行う

▲就労は医療チームを含めた多職種で協力して支援する。

▲医師が一員にいる就労支援チームでは，より高い一般就労実現率を獲得できるという研究結果がある。

▲就労前後に症状が揺らいだ時や副作用が認められる時に，早期に医師の介入が行われれば，より高い確率で就労が継続できる。

7. 就労が保障制度，収支に与える影響を事前に説明する

▲就労によってこれまで受給していた保障に影響があるか事前に確認する。

▲総収入の計算や確定申告の援助。

▲就労前，及び就労条件が変わるたび，収支内容を文書で作成し，利用者に渡す。

8.あくまでも一般雇用をめざす

▲一般雇用の定義：パート，フルタイムは問わない。誰でも申し込みができ，最低賃金が確保され，一般の労働者と同じ職場で同じ仕事内容であること。

表 1　ベルモント州精神保健の変遷

	1950	1960 & 1970	1980	1990	2000	2010＋
治療・支援内容	精神科病院への収容	雇用なし，保護的労働（院内作業）	過渡的雇用（短期，一過性），作業訓練，就労移行	就労支援，障害者雇用	IPS，一般雇用の実現	IPS，リカバリーのための一般就労
支援環境	隔離	分離	保護的	一部地域	地域主体	地域，職場
治療・支援を受ける人の立場	患者	患者	利用者	利用者	クライアント	個人，求職者
サービス設計に用いられたモデル	医学	医学，管理，保護	コミュニティー	支援	リカバリー	パーソン・センタード・ケア，リカバリー，協働ケア
治療・支援の特徴	隔離，隔絶	危険回避，保護	危険回避と保護，人権擁護運動の勃興	人権擁護，インフォームド・チョイス	意思決定の共有（SDM）	ピアサポート，ナチュラルサポート

1950 年代以降の精神保健の変遷を「治療・支援内容」「支援環境」「治療・支援を受ける人の立場」「サービス設計に用いられたモデル」「治療・支援の特徴」の 5 分野についてまとめている。1980 年代までは，入院による患者の隔離，分離が主体であったが，1980 年代以降は積極的に地域移行が進められ，2000 年からは広い範囲で IPS の実践が行われるようになった。現在では IPS のゴールは単なる就労実現ではなく，就労を介してリカバリーを促進する点に重点が置かれている。また，ピアによるサポートだけでなく，一般雇用を通じて職場の上司，同僚など一般の人々と交わることから自然なサポートを得ること（ナチュラルサポート）で精神障がい者の社会復帰やリカバリーを促進するという考えが注目されている。

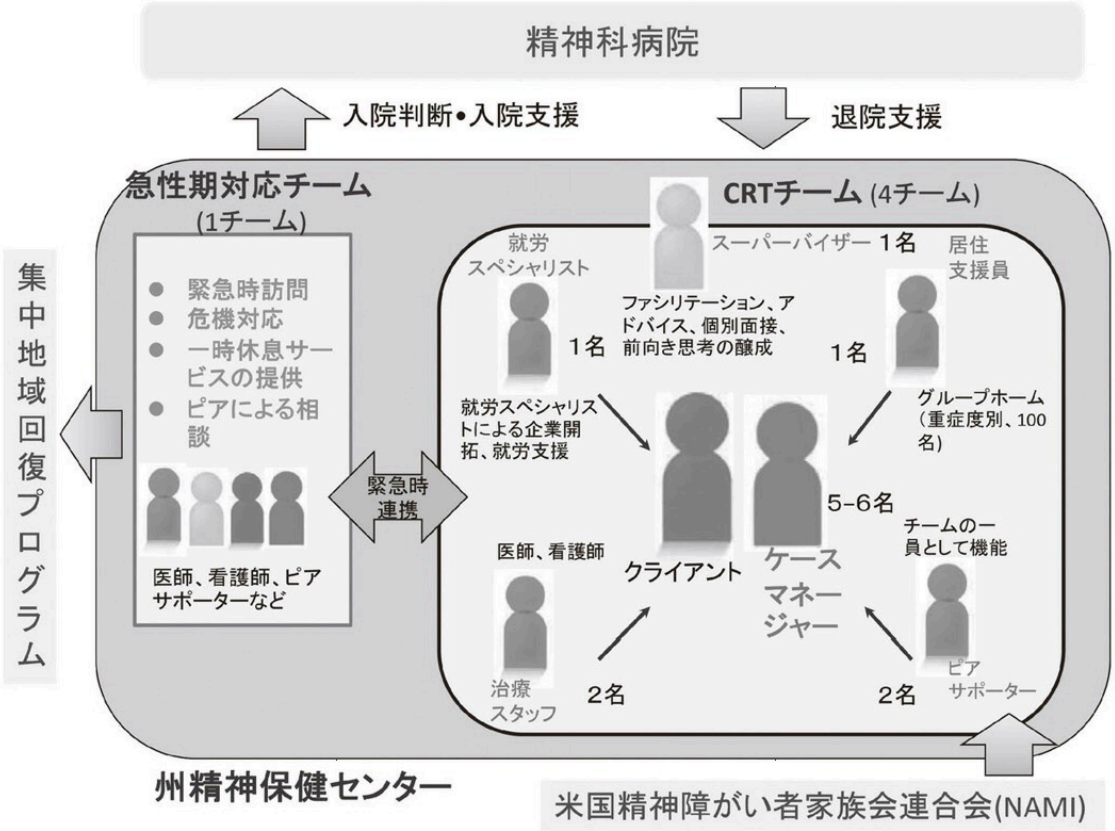

図 2　ベルモント州精神保健センターの機能

ベルモント州には 11 の精神保健センターが存在するが，その 1 つであるハワードセンターの機能を図式化した。完全チーム制で運用されており，急性期対応チームと CRT チームがある。急性期対応チームは，地域の急性増悪した利用者を往診し，入院，あるいは集中地域回復プログラムの利用の可否を判断する。CRT チームの主力部隊はケースマネージャーで，クライアント毎に担当制がとられ，生活全般の支援を行う。CRT チームは，その他に就労スペシャリスト，居住支援員（グループホーム管理人），医師，看護師，ピアサポーターを含む多職種から構成され，それぞれの専門性を生かしケースマネージャーをサポートする。チームのスーパーバイザーは，チームミーティングのファシリテーション，スタッフへのアドバイスや個別面接を定期的に行い，チーム内に前向き思考を醸成するよう働きかける。

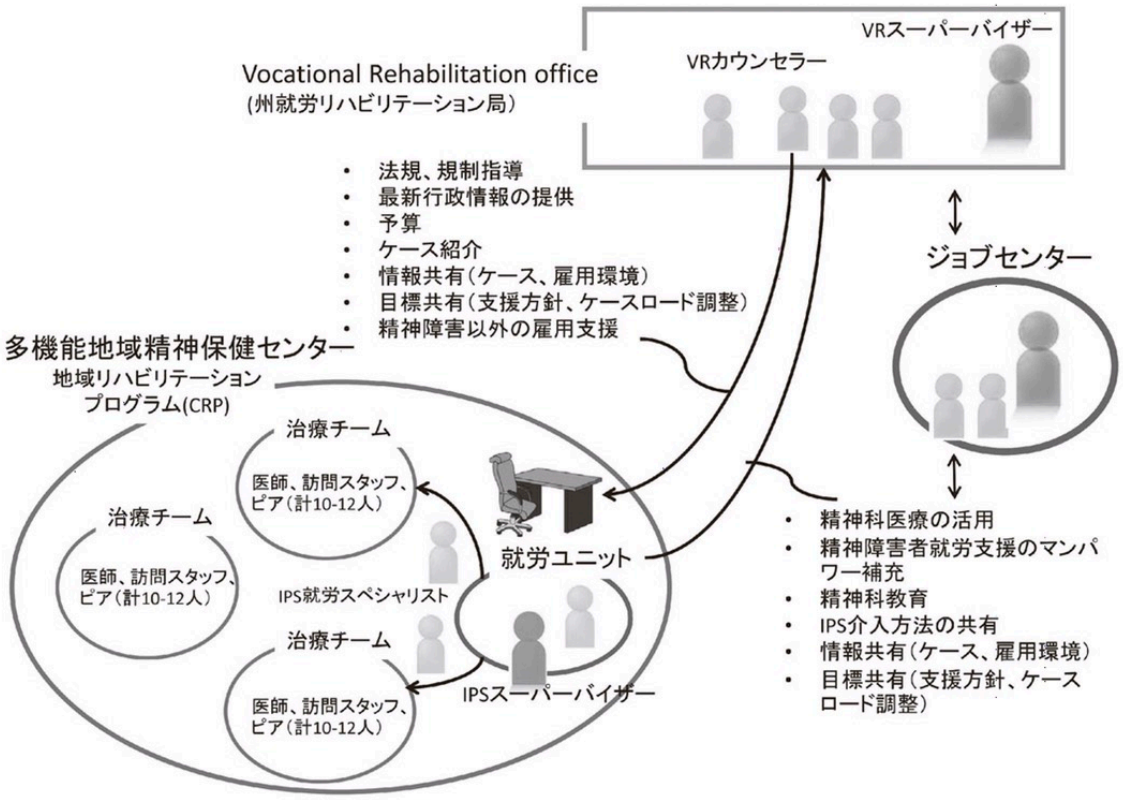

図 3　米国の IPS の運用例

図 2 に示したように地域の精神保健センターでは，就労ユニットに属する就労スペシャリストは，各治療チーム（CRT チーム）に配置されている。彼らは週に 1 回行われる就労ユニットミーティングで集まり IPS スーパーバイザーから指導を受けたり，ケースカンファレンスによる情報交換を行う。就労スペシャリストは勤務時間の 60 ～ 70% は地域で費やし，雇用主開拓や訪問に加え，障害者就労リハビリテーション局のスタッフ（カウンセラー）と協働する。カウンセラーからは新しい法規や行政情報の提供，ケース紹介が行われる。一方，就労スペシャリストは精神医療や福祉に関するアドバイスを行う。IPS と障害者就労リハビリテーション局との連携を強化するために，カウンセラーのための机を精神保健センター内に設けることがある。カウンセラーは月に 1 日程度精神保健センターで過ごし，あらゆる CRT スタッフと情報交換を行う。障害者就労リハビリテーション局は日本の障害者就業・生活支援センター，障害者職業センターに類似した役割を担うが，IPS の予算支給も行う。ジョブセンターは日本でいうハローワークに類似した役割を担う。

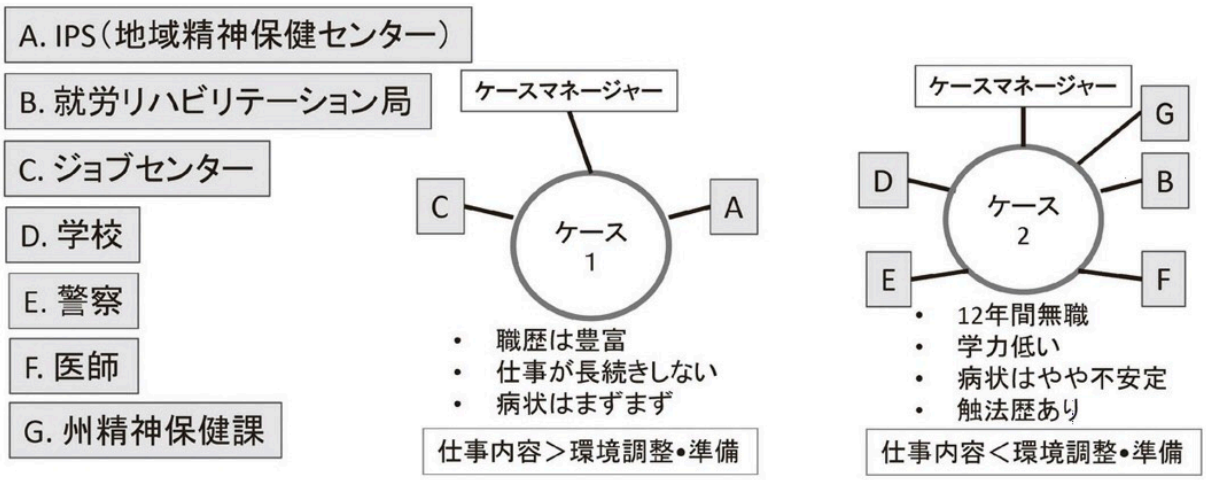

図 4　資源統合チームアプローチ（IRT：The Integrated Resource Team Approach）

障がい者雇用促進イニシアティブ（DEI）は米国労働省主導で行われている障がい者雇用促進の取り組みであるが，その一環としてコネチカット州では IRT を採用している。IRT では地域の専門家を集め，ケース毎にチームを編成し，カスタマイズ支援を行う。例えばケース１は，職歴は豊富であり，精神症状も落ち着いているが，仕事が長続きしない場合のチーム編成例である。この場合，環境調整より，仕事内容が重要となるので，マッチングを重視した職業選択と開拓がより必要となり，IPS 就労スペシャリスト，ジョブセンタースタッフとクライアントのケースマネージャーでチームを編成し支援を行う。ケース２は，長期無職で，触法歴があり，精神症状が不安定な場合のチーム編成例である。この場合，就労支援の一環として，まず教育，生活援助，治療などの環境整備が必要となるため，学校，医師，警察関係者を含んだ支援チームが結成される。所属の全く異なるチームメンバーは面会，電話連絡などの簡便な手法で連携を図る。

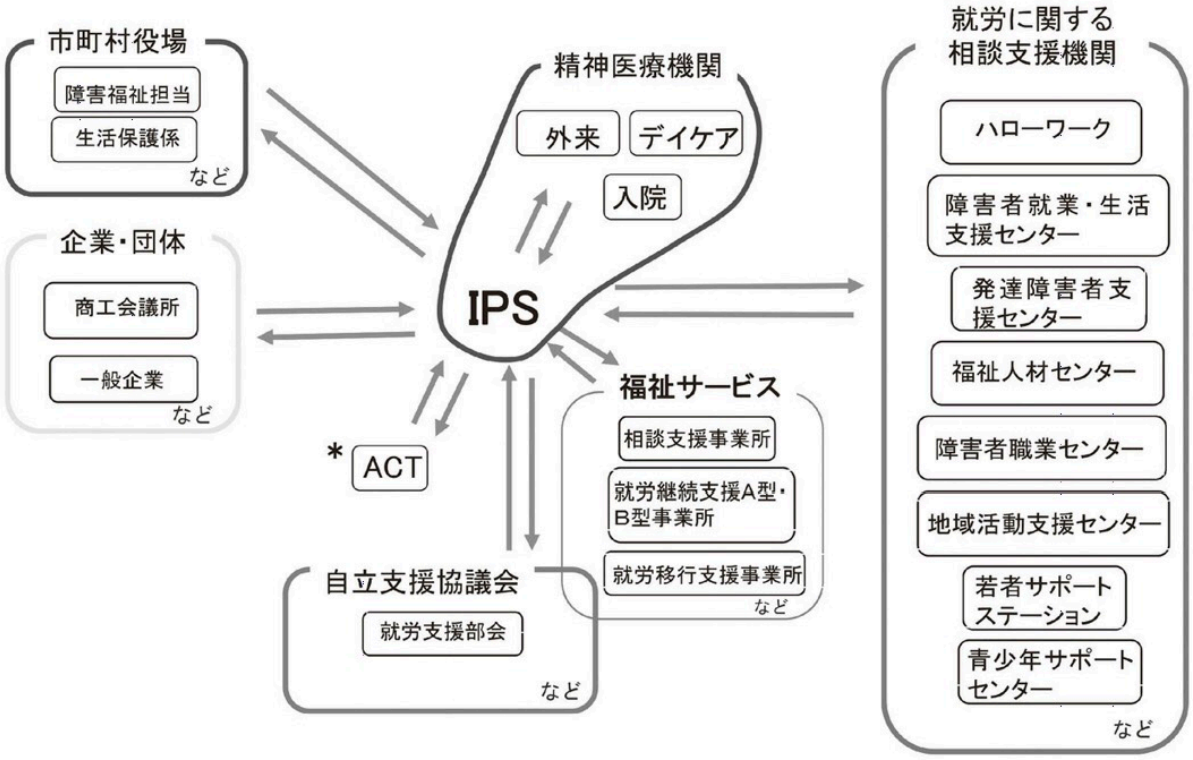

図 5　日本における IPS の実践モデル

IPS チームが医療機関内にある場合の，地域各機関との連携模式図。詳細は本文参照。*ACT（Assertive Community Treatment）は医療機関や訪問看護ステーションなどに附属する。ACT は包括型地域生活支援プログラムと呼ばれ，重度精神障がい者の地域生活を多職種で支援する。

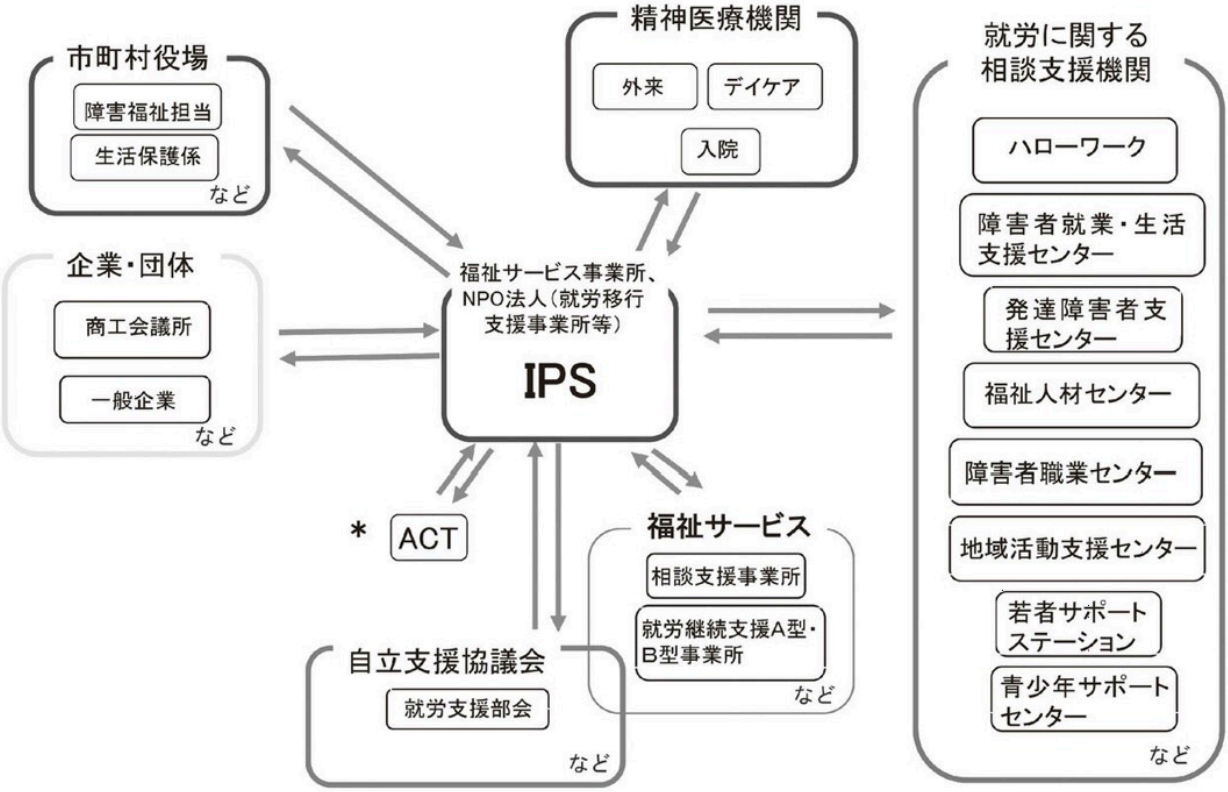

図 6　日本における IPS の実践モデル

IPS が医療機関以外の，例えば就労移行支援事業所などの福祉サービス事業所や NPO 法人で実践される場合の，地域各機関との連携模式図。詳細は本文参照。